

SEDAÇÃO PROCEDURAL — PREPARO + MONITORIZAR

NÍVEIS DE SEDAÇÃO

Nível	Resposta	Via aérea / ventilação
Mínima (ansiólise)	Responde normalmente ao comando verbal	Preservadas
Moderada (consciente)	Responde a comando/estímulo tátil	Mantém via aérea e ventilação espontânea
Profunda	Responde a estímulo doloroso repetido	Pode precisar de suporte de via aérea/ventilação
Anestesia geral	Não responde nem ao estímulo doloroso	Frequentemente requer suporte ventilatório
Conceito-chave	A sedação é um continuum — o paciente pode ir além do nível pretendido	Estar preparado para resgatar um nível mais profundo que o planejado

SEGURANÇA: PREPARO ANTES DA DROGA

MONITORIZAÇÃO, MATERIAL E PESSOAL DEDICADO

- Avaliar via aérea (Mallampati, mobilidade cervical, abertura oral) e risco (ASA, comorbidades)
- Monitorização: oximetria CONTÍNUA, PA, ECG e CAPNOGRAFIA (detecta hipoventilação antes da dessaturação)
- Material pronto: O₂, aspirador, bolsa-válvula-máscara, material de via aérea e drogas de reanimação; acesso venoso
- Pessoal: um profissional dedicado a monitorar a sedação, separado de quem realiza o procedimento
- Pré-oxigenar; ter os antídotos disponíveis (naloxona para opioide, flumazenil para benzodiazepínico)
- Jejum: considerar, mas NÃO deve atrasar procedimentos de emergência (individualizar risco-benefício)
- A complicação mais comum e temida é a depressão respiratória/hipoventilação

DROGAS PARA SEDAÇÃO E ANALGESIA

Rx ESCOLHER PELO PROCEDIMENTO E PELO PACIENTE

Cetamina: 1-2 mg/kg IV (sedação dissociativa); mantém o drive respiratório e a PA; broncodilatador; ideal em crianças e em procedimentos dolorosos

Propofol: 0,5-1 mg/kg IV, titular; início e recuperação rápidos; causa hipotensão e depressão respiratória (não tem antídoto)

Midazolam: 0,02-0,05 mg/kg IV; ansiólise/amnésia; antídoto flumazenil (cautela)

Fentanil: 1 mcg/kg IV; analgésico potente e de ação rápida; antídoto naloxona

Cetofol (cetamina + propofol): combinação que reduz a hipotensão e a depressão respiratória

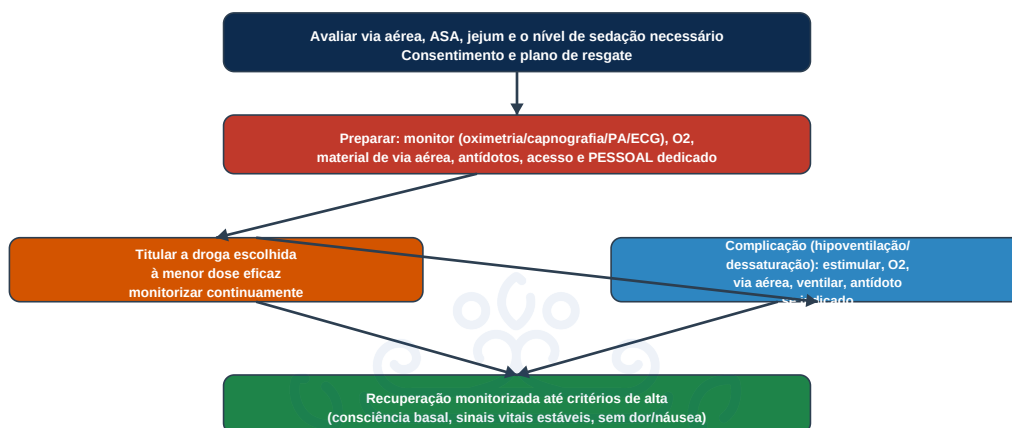
Etomidato: 0,1-0,15 mg/kg; hemodinamicamente estável; pode causar mioclonias

Óxido nitroso: ansiólise/analgesia leve para procedimentos menores

Titular sempre a menor dose eficaz e reavaliar

FLUXO DA SEDAÇÃO PROCEDURAL

SEDAÇÃO — AVALIAR, PREPARAR, MONITORAR, RECUPERAR



ESCOLHA POR CENÁRIO E RECUPERAÇÃO

Qual Droga Quando

- Redução de fratura/luxação dolorosa: cetamina ou propofol+fentanil (cetofol)
- Cardioversão elétrica: propofol ou etomidato (curta duração)
- Criança em procedimento doloroso: cetamina (mantém drive respiratório e PA)
- Paciente hipotenso/instável: etomidato ou cetamina (evitar propofol)
- Procedimento curto e pouco doloroso: midazolam +/- fentanil
- Sempre associar analgesia adequada à sedação em procedimentos dolorosos

Critérios de Alta

- Retorno ao nível de consciência basal
- Sinais vitais estáveis e via aérea segura
- Dor e náusea controladas
- Capaz de deambular conforme o basal; sem sinais de re-sedação
- Orientações por escrito; acompanhante para o domicílio
- Observar mais tempo se usou droga de ação longa ou houve complicação

CHECKLIST DE SEGURANÇA

ANTES, DURANTE E DEPOIS

- ☐ ANTES: avaliar via aérea/ASA/jejum, consentir, preparar monitor (incl. capnografia), O2, material e antídotos
- ☐ PESSOAL dedicado à monitorização, separado de quem faz o procedimento
- ☐ DURANTE: titular a menor dose eficaz; vigiar oximetria, capnografia e nível de consciência
- ☐ Complicação mais comum: depressão respiratória/hipoventilação — estimular, O2, ventilar, antídoto se indicado
- ☐ Escolher a droga pelo procedimento e pelo paciente (cetamina/etomidato se instável)
- ☐ DEPOIS: recuperação monitorizada até critérios de alta; orientações e acompanhante

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Qual método de monitorização detecta precocemente a hipoventilação durante a sedação, ANTES da queda da saturação?

- A) Pressão arterial não invasiva
- B) Capnografia (PETCO₂)
- C) Temperatura
- D) Glicemia capilar
- E) Diurese

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Em paciente hipotenso/instável que necessita de sedação para cardioversão, qual agente é preferível?

- A) Propofol em dose alta
- B) Etomidato (ou cetamina), por maior estabilidade hemodinâmica
- C) Midazolam em bolus alto
- D) Tiopental
- E) Fentanil isolado em dose alta

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é a complicação mais comum e temida da sedação procedural?

- A) Reação alérgica cutânea
- B) Depressão respiratória / hipoventilação
- C) Hipertensão
- D) Hiperglicemia
- E) Retenção urinária

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Sobre a equipe durante a sedação procedural, qual afirmação é correta?

- A) O mesmo profissional pode realizar o procedimento e monitorar a sedação simultaneamente
- B) Deve haver um profissional dedicado a monitorar a sedação, separado de quem realiza o procedimento
- C) Não é necessária monitorização contínua
- D) Os antídotos não precisam estar disponíveis
- E) A oximetria é dispensável

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual agente sedativo/analgésico mantém o drive respiratório e a pressão arterial, sendo útil em crianças e em procedimentos dolorosos?

- A) Propofol
- B) Cetamina
- C) Midazolam
- D) Tiopental
- E) Óxido nítrico isolado

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A capnografia (PETCO₂) detecta a hipoventilação precocemente, antes da queda da saturação na oximetria (que tem atraso, sobretudo com O₂ suplementar). Por isso é recomendada na monitorização da sedação procedural.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

No paciente hipotenso/instável, prefere-se etomidato (hemodinamicamente estável) ou cetamina (simpaticomimético) para sedação/cardioversão, evitando o propofol, que causa hipotensão.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A complicação mais comum e temida da sedação procedural é a depressão respiratória/hipoventilação. Por isso a monitorização (oximetria + capnografia), o material de via aérea e os antídotos devem estar prontos.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Deve haver um profissional dedicado exclusivamente a monitorar a sedação e o paciente, separado de quem executa o procedimento, garantindo a vigilância contínua e a capacidade de resgate.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A cetamina (sedação dissociativa) mantém o drive respiratório e a pressão arterial, além de ser analgésica e broncodilatadora — útil em crianças e em procedimentos dolorosos, e segura no paciente hipotenso.

SM24
Suporte ao Plantão Médico